

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Biologia Celular, Embriologia E Genética
PPG Biologia Celular e do Desenvolvimento
Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE)

Pós-doutorando: Dr. Tiago Fernando Chaves

Supervisores: Profa Dra Yara Costa Netto Muniz & Daniel Pacheco Bruschi



Case 03

Prontuário Clínico: Peter Parker

Identificação do Paciente

- **Nome:** Peter Parker
- **Data de Nascimento:** 15/08/2018
- **Idade:** 7 anos
- **Sexo:** Masculino
- **Cor:** Caucasiano
- **Registro:** OSBORN-LAB-2025-007
- **Data da Anamnese:** 12/11/2025

História Clínica (HDA) - Queixa Principal e História de Doença Atual

Paciente encaminhado para investigação de baixa estatura, anomalias esqueléticas e problemas de visão.

Queixas Esqueléticas: Os tios (Ben e May Parker) relatam que, desde o nascimento, Peter apresenta **baixa estatura acentuada** e **membros curtos** (rizomelia). Ele demonstra **caminhar com dificuldade** e possui **tórax estreito**, resultando em **respiração rápida e superficial** durante o esforço. Acompanhamento ortopédico desde a primeira infância.

Queixas Oftalmológicas: Desde os 5 anos, apresenta **dificuldade progressiva para enxergar no escuro** (nictalopia) e queixas de que a **visão lateral está diminuindo**. Utiliza óculos, mas a acuidade visual permanece subótima.

Queixas Tegumentares (Ectodérmicas): O cabelo é notavelmente **fino, ralo e de crescimento lento**. As unhas dos pés e das mãos são **distróficas, quebradiças e de formato anormal**. A dentição é marcada por **anomalias na forma e no esmalte**.

Desenvolvimento: Desenvolvimento intelectual e cognitivo típico para a idade.

História Familiar (HF)

- **Tio (Ben Parker):** Falecido.
- **Tia (May Parker):** 65 anos, saudável. Sem histórico de baixa estatura ou malformações congênitas na família.
- **Pais Biológicos:** Falecidos. Histórico médico desconhecido, mas sem relato de consanguinidade na família.
- **Histórico Secundário:** Não há parentes conhecidos com a combinação dessas anomalias.

Exame Físico

- **Estado Geral:** Alerta, cooperativo. Aparência de **criança pequena para a idade**.
- **Antropometria:** Altura: 105 cm (abaixo do P3). Peso: 17 kg (P10).
- **Dismorfias Craniofaciais:** Face arredondada, **suturas cranianas proeminentes e narinas antevertidas**.
- **Tegumento:** Cabelos finos, esparsos. Unhas hipoplásicas e distróficas. Dentes com formato anormal e cáries frequentes.
- **Torácica:** **Tórax estreito e curto** com formato em sino (bell-shaped chest).
- **Esquelético:** Rizomelia (encurtamento significativo dos ossos longos proximais, especialmente úmero e fêmur).

Exames Complementares (Achados Chave)

- **Radiografia Esquelética (Membros e Tórax):**
 - **Costelas curtas e largas** (displasia torácica).
 - **Epífises e metáfises irregulares** nos ossos longos.
 - **Bacia pequena e malformada**.
- **Oftalmologia (Exame de 10/2025):**
 - **Fundoscopia:** Presença de **pigmentação óssea periférica** e atenuação vascular. Achados compatíveis com **Distrofia Retiniana / Retinopatia Pigmentar**.
 - **Eletrorretinograma (ERG):** Respostas de bastonetes e cones reduzidas, confirmando disfunção retiniana.

- **Função Renal:**

- **Ultrassom Renal:** Rins com morfologia e tamanho normais. **Ausência de cistos ou outras anomalias renais estruturais.** (Diferentemente de outros tipos de ciliopatias graves).

Impressão Clínica (Displasia Esquelética Ectodérmica)

Paciente jovem apresentando uma **combinação de achados dismórficos, esqueléticos e ectodérmicos**, sugerindo fortemente uma patologia genética pleiotrópica.

Achados Chave Associados:

1. **Displasia Esquelética:** Baixa estatura, membros curtos, tórax estreito com costelas curtas.
2. **Distrofia Retiniana:** Retinopatia Pigmentar.
3. **Displasia Ectodérmica:** Cabelos finos/esparsos e unhas distróficas.
4. **Dismorfias Craniofaciais:** Face arredondada e narinas antevertidas.

Nota: A ausência de envolvimento renal grave é relevante, distinguindo este quadro de outras displasias torácicas mais amplas.

Plano de Conduta

1. **Investigação Etiológica:** Coleta de amostras para **Painel de Sequenciamento Genético** focado em displasias esqueléticas associadas a distrofias ectodérmicas e retinopatias.
2. **Multidisciplinaridade:** Iniciar acompanhamento com:
 - **Geneticista:** Para diagnóstico e aconselhamento.
 - **Pneumologista:** Para avaliação da função respiratória restritiva devido ao tórax estreito.
 - **Ortopedista:** Para manejo da displasia óssea.
3. **Suporte Terapêutico:** Encaminhamento para especialistas em **baixa visão e odontologia** especializada para manejo das anomalias dentárias.